Lịch tiêm chủng điều chỉnh thích hợp theo tuổi này tạo ra mức độ đáp ứng kháng thể IgG kháng polysaccharid vỏ bao đối với mỗi loại trong 13 týp huyết thanh ít nhất tương đương với đáp ứng của đợt tiêm chủng chính gồm 3 liều ở trẻ sơ sinh.

Bảng 4. Nồng độ trung bình nhân của kháng thể IgG polysaccharid kháng vỏ phế cầu khuẩn (µg/ml) 1 tháng sau khi tiêm chủng (trong Nghiên cứu 6096A1-3002)

Týp huyết thanh	Tuổi từ 7 đến 11 tháng (N=83-84)	Tuổi từ 12 đến 23 tháng (N=104-110)	Tuổi từ ≥ 24 tháng đến 5 tuổi (N=135-152)
1	2,88	2,74	1,78
3	1,94	1,86	1,42
4	3,63	4,28	3,37
5	2,85	2,16	2,33
6A	3,72	2,62	2,96
6B	4,77	3,38	3,41
7F	5,30	5,99	4,92
9V	2,56	3,08	2,67
14	8,04	6,45	2,24
18C	2,77	3,71	2,56
19A	4,77	4,94	6,03
19F	2,88	3,07	2,53
23F	2,16	1,98	1,55

Việc tiêm đồng thời với các vắc xin khác ở trẻ sơ sinh và trẻ em

Trong nghiên cứu 6096A1-004, 6096A1-3005 và 6096A1-3008, các vắc xin dùng thường quy cho trẻ em được dùng trong cùng đợt với Prevenar 13. Đáp ứng đối với kháng nguyên vắc xin khác dùng đồng thời được so sánh ở trẻ sơ sinh được tiêm vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn và Prevenar 13. Tỉ lệ những người đáp ứng ở mức độ kháng thể định trước được trình bày ở Bảng 5. Các đáp ứng cho tất cả kháng nguyên ở trẻ nhận Prevenar 13 tương đương với đáp ứng của trẻ nhận vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn và thỏa mãn tiêu chuẩn chính thức về tính không thua kém. Đáp ứng thủy đậu đo bằng bộ kit ELISA tế bào toàn phần thương mại, được thiết kế để phát hiện tính miễn dịch sau khi nhiễm trùng tự nhiên, đều thấp trong cả hai nhóm, nhưng không có bằng chứng đáp ứng miễn dịch bị nhiễu do Prevenar 13 tiêm đồng thời.